

45. 피부발진

• 중요 포인트

- 1. 발진의 위치를 정확히 확인 – 처음 생긴 곳, 퍼진 위치, 현재 어디어디
- 2. 신체 검진 시 발진을 꼼꼼히 시진, 촉진 (환자가 인지하지 못한 곳에 있을 수도 있음)
- 3. 원인 인자 확인 – 발진이 생기는 상황, 가족구성원/본인 알레르기, 아토피 유무 확인
- 4. 교육: 씻을 때 중성비누, 물기 잘 말리고 건조하지 않게 보습제 바르기
- 5. 가려움증 심하면 항히스타민제 처방

중요성: 일차적인 질환으로 올 수도 있고 다른 전신질환의 단서가 될 수 있다. 피부 병변의 특성을 파악하여 원인질환을 조기에 감별하는 것은 질병의 치료와 전파 예방에 중요하다.

원인			
알레르기 피부염		접촉성 피부염, 약진 등	
감염성 피부질환		바이러스 발진 등	
면역성 질환		루푸스 등	
평가목표			
1) 피부 병변의 특성을 파악하여 원인적인 진단과 치료 방침 수립			
2) 필요한 경우 환자의 자가 조치에 대해 교육할 수 있는지 평가			
구체적인 성과			
병력 청취	피부 발진의 특성 확인	위치: 처음에 어디에서 생겼고, 어디로 퍼졌고, 지금 현재 어디있는지 확인 양상 1) 개수/크기/모양/색깔 2) 딱지/물집/비늘 3) 열감/발적/부종/가려움/따가움/압통 4) 여러 개가 하나로 합쳐지는지	
	피부 이외 장기 질환과의 인과관계	감염: 발열/오한/감기기운/오심/구토/설사/호흡곤란/기침/가래/인후통/위험한 성관계 류마티스: 관절통/햇빛 노출부위 발진/거품뇨/구강궤양/성기궤양/팔다리 근력약화 콜린성 두드러기: 찬물/땀 닿으면 악화 알레르기: 약물/음식	
신체 진찰	국소적인 병변의 특성 확인	발진 부위 및 전신 진찰 시진 1) 위치/모양/분포: 발진 부위 / 눈, 코, 구강, 머리카락 사이, 팔다리, 손발톱, 상의 탈의하여 몸통 모두 시진 2) 고름/가피 여부, 2 차적 병변 여부(삼출물, 농, 비늘, 태선화) 촉진 1) 눌러봄 (erythema/petechia 구별) 특수검사 1) 아토피 의심 시 설압자로 긁어 피부묘기증 확인 2) 수포성 병변 시 병변 표피를 면봉으로 밀어 표피 박리 확인 (니콜스키 징후)	
	피부 발진과 관련된 다른 질환의 소견을 확인	V/S 확인, 눈(결막, 공막), 구강(궤양) 목: 경부 림프절 촉진 (감염) (류마티스 의심 시) 심음청진, 호흡음청진 관절 시진, 촉진(압통) ROM 평가	
	질환	진단	치료
진단	바이러스 발진 (홍역, 수두) (1+1)	CBC, 혈청검사	대증치료, 항바이러스제(성인 수두)
및	2 기 매독	VDRL test, TPHA, FTA-ABS	Benzathine penicillin IM

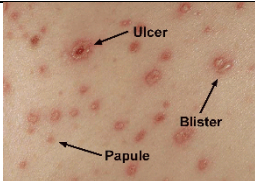
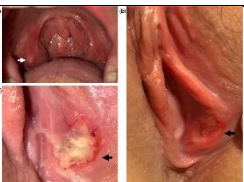
치료	대상포진 (0+1)	검사 불필요(간혹 PCR)	항바이러스제, 스테로이드, 통증조질: NSAID, opioid, 항우울제, 항경련제
	옴	병변 부위 긁어서 현미경으로 봄 (손가락 사이, 손목 안쪽, 성기에 굴)	가족 동시 치료, 퍼메트린 연고 (얼굴 제외 도포 후 8 시간 후 씻음)
	몸백선 (1+0)	KOH 도말검사	건조하고 시원한 환경 유지, 국소 항진균제
	어루러기	우드등검사, KOH 도말검사, 진균배양	
	건선	피부조직검사, 임상진단	보습, 국소 스테로이드, 광선치료, retinoid, cyclospoin, 생물학제제
	접촉피부염 (1+1)	채포검사, 유발검사	원인물질회피, 냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
	약물발진 (3+0)	의심되는 약 사용 금지, 고정약진·채포검사	약 끊고 스테로이드 항히스타민제
	아토피 피부염 (1+0)	피부바늘따끔검사, 혈청 IgE	피부 보습, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제, 생물학제제
	쿨린성 두드러기 (1+0)	운동유발시험, 온열 검사	유발요인 회피(과도한 운동, 사우나, 맵고 뜨거운 음식), 항히스타민제
	전신홍반루푸스	CBC, 항핵항체, anti-dsDNA	국소 스테로이드, hydroxychloroquine, glucocorticoid
	베체트병 (1+0; 결절홍반)	Pathergy test(이상초과민검사), 결절성 홍반	피부: colchicine 구강, 신경, 안구: glucocorticoid
	피부근염	근전도, 근육효소(CK), 근육조직검사	국소/전신 스테로이드, 면역억제제
	가려움증 등 병변 조절에 필요한 처치	항히스타민제 처방	
환자교육		1) 유발요인 방지: 음식, 찬물/땀, 꽃가루, 동물, 약물 등 원인 물질 회피 2) 자가 조치: 중성비누 사용, 보습 충분히(로션, 보습제), 병변 부위 긁지 말 것, 심한 운동이나 더운 목욕 피하기, 땀 잘 흡수하는 면 제품 착용, 스트레스 줄이기	
윤리적 법적 고려		전염성 피부질환에 대한 신고/격리 1) 수두, 홍역: 2 급 감염병 – 24 시간 이내 신고, 격리 i) 수두: 모든 병변에 가피가 생길 때까지 (발진 발생 후 최소 5 일간) ii) 홍역: 검사 확인 전 의심단계에 격리, 발진 4 일 전부터 4 일 후까지 (발진 ± 4) 증상 심하지 않으면 자택격리 2) 매독: 3 급 감염병 – 24 시간 이내 신고	
의사소통/환자의사관계		성매개성 질환을 의심하는 경우 환자에게 심리적인 지지를 얻은 다음 자발적 답변을 얻는 병력청취	

[감별진단] + 수족구

질환		병력취취	질환설명	발진 위치/특징	검사	치료
감염	바이러스 발진 (홍역, 수두) 1+1	발열, 감기 증상 홍역: 3C(기침, 콧물, 결막염) + Koplik's spot		중심부 □ 주변부 전신 피부 발진 수두: 다양한 형태	CBC, 혈청검사	대증치료, 항바이러스제(성인 수두)
	2기 매독	발열, 감기 증상 위험한 성관계		전신, 손, 발 외음부 궤양 (+/-)	VDRL test, TPHA, FTA-ABS	Benzathine penicillin IM
	대상포진 0+1	2~3 일 후 통증 노인, 면역억제자	바이러스가 잠복해있다가 면역력이 떨어지면서 다시 증상 일으킴	일측성, dermatome 고름, 딱지, 궤양	검사 불필요(간혹 PCR)	항바이러스제, 스테로이드, 통증조절: NSAID, opioid, 항우울제, 항경련제
	몸백선 1+0	가려움, 각질	곰팡이균(피부사상균=무증균)이 몸에 감염된 것	목, 팔, 다리, 몸 고리형 병변, 중앙은 피부색, 주변 경계부위는 하얀 각질 동반한 잔물집, 붉은 구진	KOH 검사	건조, 시원한 환경 유지, 국소 항진균제
	옴	가족 중 유사 증상, 밤에 심해지는 가려움증	옴 진드기가 피부 각질층에 굴을 파고 들어감	사타구니, 하복부, 겨드랑이 심한 가려움 잠 잘 때(밤에) 심함	병변 부위 긁어서 현미경으로 봄 (손가락 사이, 손목 안쪽, 성기에 굴)	가족 동시 치료, 퍼메트린 연고 (얼굴 제외 도포 후 8 시간 후 씻음) 침구, 옷 뜨거운 물에 세탁
	어루러기	무증상 ~ 경미한 가려움증	곰팡이균 감염	땀 많은 부위 (가슴, 등, 겨드랑이, 목) 얼룩덜룩한 반점 (흰색, 갈색)	우드등검사, KOH 도말검사, 진균배양	건조하고 시원한 환경 유지, 국소 항진균제
염증	건선	손발톱 변화	면역세포가 피부 각질세포를 자극해 각질세포의 과다 증식과 염증을 일으켜서 각질이 겹겹이 쌓이는 질환	팔꿈치, 엉덩이, 두피 구진 □ 뭉쳐서 판 위에 은백색 비늘이 겹겹이 쌓여 나타남	피부조직검사, 임상진단	보습, 국소 스테로이드, 광선치료, retinoid, cyclosporine, 생물학제제
	접촉 피부염 1+1	비누, 샴푸, 세제, 화장품, 벨트, 목걸이 등과 접촉	접촉한 물질 자체의 자극에 의해, 또는 접촉물질에 대한 알레르기 반응에 의해 생기는 피부염	접촉 부위 접촉 부위에만 발진	접촉검사, 유발검사	원인물질회피, 냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
알레르기	약물 발진 3+0	고정 발진: 동일한 약을 복용할 때만 발진 생		1) 전신발진 2) 고정약진: 동일 부위 유사 병변 과색소 침착	의심되는 약 사용 금지, 고정약진 □ 철폐검사	약 끊고 스테로이드 항히스타민제
	아토피 피부염 1+0	가려움증, 피부건조 알레르기 질환 가족력	만성 염증성 피부염	2 세 미만: 얼굴, 사지팔쪽 2 세 이상: 얼굴, 목, 사지굴힘쪽 습진성 병변	피부바늘따끔검사, 혈청 IgE	피부 보습, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제, 생물학제제
	콜린성 두드러기 1+0	운동/땀에 의해 악화	운동, 스트레스, 뜨거운 목욕으로 심부 체온이 1°C 정도 상승했을 때 두드러기가 발생하는 것		운동유발시험, 온열 검사	유발요인 회피(과도한 운동, 사우나, 맵고 뜨거운 음식), 항히스타민제

류 마 티 스	SLE	광과민성, 구강 궤양, 관절염, 거품뇨	만성 염증성 자가면역질환 (우리 몸의 면역체계가 자기 자신을 공격)	malar rash(nasolabial fold), discoid rash	CBC, 항핵항체, anti-dsDNA	국소 스테로이드, hydroxychloroquine , glucocorticoid
	베체트병 (결절홍반) 1+0	포도막염, 관절염	전신의 혈관에 염증이 발생하는 자가면역질환	구강, 생식기 궤양	Pathergy test(이상초과민검 사), 결절성 홍반	피부: colchicine 구강, 신경, 안구: glucocorticoid
	피부근염	머리빗기 어렵고 계단 오르기 어려움, 팔다리 근위부 근력 약화	골격근에 염증이 생기는 자가면역질환	눈 주위: heliotrope rash 손: gottron papule	근전도, 근육효소(CK), 근육조직검사	국소/전신 스테로이드, 면역억제제

결절홍반: (감염) HSV, 사슬알균, 결핵균 / (약물) 항생제, 경구피임약 / (암) 백혈병, 림프종 / (만성염증질환) 베체트병, IBD 등 다양한 원인에 대한 과민반응. 급성으로 통증, 압통, 국소열감 동반 / 주로 정강이나 발목

홍역	수두	2 기 매독	대상포진
			
옴	어루러기	건선	접촉피부염
			
약물 발진	아토피 피부염	콜린성 두드러기	Malar rash
			
Discoid rash	베체트병	Heliotrope rash	Gottron's papule
			

O	언제 24 시간 이내(두드러기) vs 24 시간 이상(발진) Open Q 특별한 상황
L	[처음/지금] 어디에 처음 생겨서 어디로 퍼졌나요? □ 지금은 어디어디에 있나요
D	얼마나 오래/얼마나 자주 밤/낮 변화 옴: 밤에 심함
Co	크기/부위가 커지나요? / 개수 늘어나나요? 증상(가려움 or 통증)이 더 심해지나요?
Ex	이전? -> 피부과 치료?
C	[양상①] cscs 개수 count / 크기 size / 색깔 color / 모양 shape □ 발진이 여러 개가 하나로 합쳐지기도 하나요?

	모수크색 [양상②] 물집 / 비늘 / 딱지 / 가려움 / 따가움 <i>아름따가움가려움뜨거워빨개비늘딱지 물개비늘가따</i> [염증] 열감 / 발적 / 부종 / 압통 <i>발발부통</i> 일상생활 지장 - PPI	
F(피부과)	Open Q 언제 발진이 더 심해지나요? <i>매콜음식접촉</i> -접촉 [접촉피부염] 새로운 비누, 화장품, 옷 접촉 [2 기 매독] 위험한 성관계 - 비밀보장 -음식 [음식 알레르기] 음식 (뭐 먹었는지) -운동 [콜린성 두드러기] 찬물 / 땀 / 운동 -환경 [음, 백선증] 습한 환경, 불결한 침구류, 한동안 씻지 못한 적?	
A	[전신] 발열 / 오한 / 피로 / 체중변화 / 감기기운 / 근육통(<i>피부근염</i>) / 관절통(<i>SLE</i>) [호흡기] 기침 / 가래 / 콧물 / 인후통 (<i>감기증상-홍역/수두</i>) [소화기] 오심 / 구토 / 설사 [알레르기] 입술 부종 / 호흡곤란 [류마티스] - [신장] 거품뇨 - [피부] 구강, 성기 궤양/ 햇빛 노출 부위에 피부 발진이 잘 생기나요? - [신경] 팔다리 힘빠짐	
E	이전 건강 검진	
외	수술	
과	알레르기 천식 / 비염 / 아토피 피부염 / 알레르기(특정 음식, 꽃가루, 동물) / 최근 감기	
약	현재 복용 / 최근 새롭게 먹는 약, 건강보조식품 □ (지금은 안 먹는다면) 약물을 중단하면 좋아지나요?	
사	술담커 / 직업 / 스트레스 / 식습관 / 운동 여행 벌레 물린 곳	
가	비슷한 증상 (<i>음</i>) 가족 중 천식 / 비염 / 아토피 피부염 / 알레르기	
여	월경 주기 규칙적 / 월경량 / 질분비물 / 성교통	
추가로 말씀하고 싶으신 내용 있으신가요?		
P/Ex	전신	눈 □ 구강(궤양) □ 목(경부 림프절) □ (류마티스 질환 의심 시 흉부 심음/호흡음 청진) V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1) 눈: 결막, 공막 2) 입: 궤양 3) 목: 림프절 (감염) 류마티스질환 의심 시 1) 심음, 호흡음 청진 2) 관절 시진(발적, 부종, 변형), 촉진 (압통) 3) ROM 검사
	피부발진	[시진(위치/모양)] 발진 부위/(전신탈의)눈, 코, 구강, 머리카락 사이, 팔다리, 손톱, 발톱, 상의 탈의하여 몸통 모두 [발진(모양/분포)] 고름이나 가피 여부, 2 차적 병변 여부(삼출물, 농, 비늘, 태선화) 확인 [촉진(erythema/petechia 구별)] 제가 한 번 눌러보겠습니다. 아프면 말씀하세요. [특수검사] - 아토피 의심 시 설압자로 긁어서 피부묘기증 확인

		- 수포성 병변 시 니콜스키 징후 확인 (병변 표피 부위를 면봉으로 밀어 표피 박리 확인)	
검사 치료	기본검사	혈액검사: CBC, 혈청 IgE, 염증수치, 자가항체 미생물검사: 진균 – 우드등검사, KOH 검사 접촉피부염: 철포검사 (의심 물질 부착 후 2 일째, 4 일째 피부 반응 확인)	
	기본치료	감염: 항바이러스제, 항진균제 염증/알레르기/류마티스: 스테로이드, 보습제, 항히스타민제	
	홍역,수두	CBC, 혈청검사	대증치료, 항바이러스제(성인 수두)
	대상포진	검사 불필요(간혹 PCR)	항바이러스제, 스테로이드, 통증조절: NSAID, opioid, 항우울제, 항경련제
	몸백선	KOH 도말검사	건조하고 시원한 환경 유지, 국소 항진균제
	접촉피부 염	철포검사, 유발검사	원인물질회피 , 냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
	약물발진	의심되는 약 사용 금지, 고정약진[철포검사]	약 끊고 스테로이드 항히스타민제
	아토피 피부염	피부바늘따끔검사, 혈청 IgE	피부 보습, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제, 생물학제제
	콜린성 두드러기	운동유발시험, 온열 검사	유발요인 회피(과도한 운동, 사우나, 맵고 뜨거운 음식), 항히스타민제
	베체트병	Pathergy test(이상초과민검사), 결절성 홍반	피부: colchicine 구강, 신경, 안구: glucocorticoid
교육	[안심] 정확한 원인을 파악해 치료하면 증상이 많이 좋아지실 것입니다. [응급] 아나필락시스 – 갑자기 호흡곤란, 어지러움, 두근거림 발생 시 빨리 병원에 와서 응급처치 받아야 [회피] 원인물질 회피: 음식, 찬물/땀, 꽃가루, 동물, 약물 등 [교정] 중성비누 사용, 보습 충분히(로션, 보습제), 병변 부위 긁지 말 것, 심한 운동이나 더운 목욕 피하기, 땀 잘 흡수하는 면 제품 착용, 꽉 조이는 옷 피하기, 스트레스 줄이기 [격리/신고] – 전염성 피부질환 수두, 홍역: 2 급 감염병 -> 격리, 신고 필요 i) 수두: 모든 병변에 가피가 생길 때까지 (발진 발생 후 최소 5 일간) ii) 홍역: 검사 확인 전 의심단계에 격리, 발진 4 일 전부터 <u>4 일 후까지</u> (발진 ± 4) 증상 심하지 않으면 자택격리 매독: 3 급 -> 신고		

교육	공통	아나필락시스: 갑자기 숨을 잘 못 쉬겠거나 어지럽고 가슴이 두근거리는 등의 증상이 발생하면 반드시 병원에 오셔서 응급 조치를 받으셔야 합니다.
	접촉성 피부염	재접촉 피하기
	아토피 피부염	청결 유지, 보습 신경쓰기, 가려워도 긁지 않기
	바이러스 발진	안정 취하기
	대상포진	50 세 이상: 예방접종(싱그릭스, 조스타박스)
	어루러기	면역력 관리(재발 잘함), 피부 위생 관리(땀나면 옷 갈아입기, 몸 청결, 통풍이 잘 되는 옷)
	전신 홍반성 루푸스	평상시 자외선 차단제를 잘 발라주시고, 금연 및 운동해주시면 증상 개선에 도움이 됩니다. 이런 자가면역질환은 심장이나 폐처럼 중요한 기관을 나쁘게 하는 경우가 있어서 앞으로 주기적으로 검진을 받으셔야 합니다. 혹시 임신계획이 있다면 유산되기 쉽기 때문에 임신 전에 의사에게 상담을 꼭 받으셔야 합니다.

	베체트병	관절을 쉬게 하기, 관절에 무리가 가지 않는 근력운동 정기검진(눈, 폐, 콩팥 등) 금연
	피부근염	물리치료: 관절의 운동범위를 유지하기 위해 물리치료를 받으시면 좋습니다.

